

IMC =		☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS			
Luis Carlos Andriani Mondini			
IDADE: 67a	PESO: 83a	ALTURA: 175	PROFISSÃO: Dentista
SINTOMAS:			
QUEIXAS: memória ruim / Baba / MID edema / Dor mms.			
MEDICAMENTOS: B12 + Dexametasona / carnabidiol / goma (THC)			
CA Bexiga / ↑ colesterol / Dor cervical. ↳ 17hr			
MÉDICO: Dr. Mario Jorge			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: Exerc. físico (3x) corra / (3x) Pilates			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 19:30 20:00			
HORA QUE DORME: 21:30 - 22		HORA QUE ACORDA: 1:50	
COCHILLO (X) SIM () NÃO 20		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM (X) NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: (5 anos)			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 2X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: bronquite MALLAMPATI:		IAH: 38.8 e/ev SPO2: 84%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA max. Dream wear. (M).			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS { Dor cervical e lombar, ansiedade.			
26/03 - P: automática.			
24 não veio.			
07/05 P = 7.4 cmH ₂ O ajuste a masc.			
24 m. de uso: 5hr			
Fuga = 14.7 e/pm.			
IAH = 3.6 e/ev			
fuga.			
11/06 P = 7.4 cmH ₂ O			
24 IAH = 1.5 e/ev			
m. de uso: 5h 19'			
13/01 não compareceu a consulta			
26 fuga			

Nome: LUIZ CARLOS ANDRIONI MONDINI

Data de Nascimento: 11-3-1957

IMC: 27,10

Sexo: Masculino

Data do exame: 12-11-2023

Peso: 83 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DR. MARIO SILVA JORGE

Medicamentos:

Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 491,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 3,5 e 112,5 minutos. O tempo total de sono foi de 419,0 min, eficiência de 85,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 62,3%; estágio N3: 16,1%; sono REM: 18,7%. O índice de despertares foi de 26,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 38,8/hora, sendo 41 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 155 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 84%, permanecendo 5,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 72 bpm e NREM de 46 - 75 bpm.

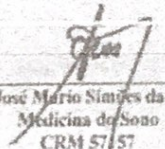
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 38,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=84%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (22,9/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento. Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157